Diskussion 2135

Datum: 1938-03-18
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 14
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Anders Andersson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag har på denna punkt tillsammans med herr Andersson i Igelboda väckt en motion, som rör internering av återfallsalkoholister. Jag vågade icke deltaga i debatten om alkoholistanstalten på Svartsjö, då jag icke haft tillfälle att besöka densamma och därför icke känner där rådande förhållanden.

I fråga om uppdelningen av vården av alkoholister är det ju ordnat på så sätt, att staten helt bekostar vården å Venngarn och Svartsjö, under det att staten i övrigt lämnar ett driftkostnadsbidrag till erkända enskilda vårdanstalter.

Man torde rätt allmänt vilja göra den uppfattningen gällande, att de enskilda anstalterna i större eller mindre utsträckning tillkommit på grund av enskilt förvärvsintresse. Jag vågar bestämt hävda, att så icke är förhållandet. Dessa anstalter ha tillkommit av rent socialt intresse och uppbäras av en social och filantropisk inställning.

Vid upprättandet av de enskilda anstalterna lämnar staten ett bidrag med 2,000 kronor per plats, då det gäller nybyggnad, och 1,500 kronor per plats vid ombyggnad. Till driftkostnader utgår ett bidrag från 3 kronor 80 öre till 4 kronor 25 öre per dag och plats. Detta bidrag utgår även intill ett dagantal av 15, då en patient lämnar anstalten på grund av permission. Undantag från denna regel utgör endast Hagbyhemmet, d. v. s. alkoholisthemmet för **kvinnor** ¹. Till detta utgår ett ständigt fast bidrag av 1 krona per vårdplats och ett driftbidrag av 3 kronor 25 öre per dag och vårdad patient.

I den motion, som vi ha framlagt, ha vi hemställt, att samma princip skall tillämpas för de erkända anstalterna. Vi ha påyrkat detta av den anledningen,

att dessa anstalter i sådant fall skulle få ett fastare ekonomiskt underlag. Vid en sådan anstalt har man alltid att räkna med vissa fasta kostnader, som äro lika, oberoende av om anstalterna äro fullbelagda eller icke, såsom kostnader för värme, inventarier, avlöning till personal o. s. v. Vissa tider, t. ex. under hösten och vintern, äro anstalterna i allmänhet fullt belagda, vilket däremot icke är fallet under andra tider på året, särskilt under sommaren. Då

uppstår svårigheter för dessa anstalter att hålla sin ekonomi flytande. Detta kan medföra det resultatet, att vederbörande anstaltsledning kan känna sig mer eller mindre föranlåten att behålla en patient kvar på anstalten för att komma i åtnjutande av statsbidraget, oavsett om vederbörande skulle kunna utskrivas, för att därigenom kunna få möjlighet att hålla sin ekonomi uppe. Jag tror nu icke, att sådant förekommer, men betonar, att det kan inträffa under dylika förhållanden. Jag har här tillgänglig en utredning, som verkställts vid hemmen på Älfgården och Björknäs, och som visar, att om det förslag, som vi framfört i motionen, blivit tillämpat, skulle detta icke behövt medföra någon merkostnad för staten. Det skulle emellertid föra med sig mera ordnade förhållanden och mera stadgad ekonomi vid anstalterna.

Behov av nya vårdplatser för alkoholister föreligger alltjämt; och när lagen om bötesstraffets förvandling till vård på alkoholistanstalt och den nya lagen om länsnykterhetsnämnder träder i tillämpning, kommer helt säkert detta vårdbehov att ytterligare ökas. Men det är icke enbart detta behov, som gör sig gällande. Det behövs dessutom enligt min mening — och jag vågar hävda, att denna uppfattning även företrädes av dem, som ha ansvaret för denna vård — en allmän översyn av hela alkoholistvården. Det brister t. ex. i fördelningen av klientelet. Det vore synnerligen önskvärt, om man kunde skicka unga alkoholister till en särskild anstalt, återfallsalkoholister till en annan, asociala parasiterande alkoholister till en tredje o. s. v. Det vore vidare ett önskemål, om man kunde åstadkomma litet fastare reglering beträffande antalet platser. Om nya platser å en enskild anstalt skola inrättas, borde detta ske i fullständigt samförstånd med socialstyrelsen. På detta sätt skulle man få en viss kontroll över att anstalten fyller det behov, som förefinnes, och att det icke uppstår ett övertaligt antal platser.

De enskilda alkoholistanstalterna ha enligt min mening en synnerligen stor uppgift att fylla. Eftersom inkomsterna av rusdryckshanteringen omhändertagas av staten, borde det väl också vara statens plikt och skyldighet att lämna bidrag till den enskilda alkoholistvården på ett sådant sätt, att de personer, som av socialt intresse ställt sig till förfogande för att taga hand om mer eller mindre förfallna individer 1 samhället, icke behöva göra några ekonomiska uppoffringar.

Utskottet har även i viss mån ställt sig välvilligt till de synpunkter, som framförts i motionen. Jag är givetvis synnerligen tacksam för detta, men jag skulle dessutom vilja rikta en allvarlig och vördsam vädjan till chefen för socialdepartementet, att han ville taga frågan om alkoholistvården i dess helhet under omprövning för att komma fram till enhetligare och fastare normer beträffande alkoholistvårdens organisation och kostnader.

Till utskottets utlåtande är fogad en reservation av herr Oscar Olsson m. fl., i vilken yrkas bifall till den motion, som jag och min medmotionär väckt. Ett bifall till densamma skulle endast innebära ett erkännande av samma princip, som regeringen har gått in för i fråga om vårdkostnaden för **kvinnliga**[1] alkoholister. Det förefaller mig endast vara en enkel gärd av rättvisa, att samma princip kommer i tillämpning även beträffande övriga erkända

alkoholistanstalter.

2. Robert Jansson (Socialdemokraterna, man)

Jag har ingen anledning att ingå i någon polemik med den föregående ärade talaren. Jag delar i stort sett hans uppfattning, att statsmakterna böra vidkännas den kostnad, som alkoholistvården förorsakar Vederbörande kommuner och landsting och i vissa fall måhända även enskilda.

Vi äro emellertid icke riktigt överens om vilka vägar man bör gå för att nå detta syfte. Motionärerna föreslå vad jag skulle vilja kalla för luftplatser, d. v. s. att bidrag skall utgå även för icke belagda platser, såvitt platserna äro godkända. Denna princip tillämpas i viss utsträckning redan nu för att möjliggöra permittering från alkoholistanstalterna i syfte att pröva det klientel, som möjligen kan utskrivas. Inom utskottet ha vi icke ansett, att det är rådligt att fortsätta på denna väg längre än vad hittills har skett. På detta sätt skulle anstalterna kunna frestas att driva en osund ekonomisk politik. Vi ha ju att räkna med enskilda alkoholistanstalter, och erkända anstalter. Dessa senare ha visserligen en annan karaktär, men vi ha likväl inom utskottet ansett, att det allmännas inflytande på ledningen av dessa anstalter inte är av den art, att det kan vara rådligt, att man lämnar bidrag för icke belagda platser.

Som skäl för sin framställning åberopa motionärerna, att denna princip tilllämpas vid den **kvinnliga[1]** alkoholistanstalten. Detta är ju visserligen sant, men å andra sidan ha vi ett så litet antal platser, som äro avsedda för **kvinnor[1]**, och det har heller inte förelegat något större behov att bygga anstalter för **kvinnor[1]** av denna kategori. Detta medverkade till att det i detta fall ansågs skäligt att lämna garantibidrag med 1 krona per dag och vårdplats.

Motionärerna påyrka nu ett bidrag av 2 kronor per dag och vårdplats för de erkända alkoholistanstalterna. Vi ha inom utskottet av de skäl jag anfört icke ansett, att man bör utöka det hittills utgående bidraget, men vi ha särskilt poängterat, att staten själv borde vidtaga åtgärder för att dra försorg om alkoholisterna och åtminstone övertaga den svåraste och dyrbaraste anstaltsvården. Kunna vi komma därhän, föreligga inga skäl att ändra gällande bestämmelser för bidragstilldelningen.

Departementschefen har på grund av gjorda framställningar förklarat, att han icke kunnat vara med om att förändra grunderna för statsbidragets fördelning. Vi ha inom utskottet anslutit oss till tlepartementschefens uppfattning i föreliggande fall.

Jag måste vidare säga, att reservationen är litet konstig. Det yrkande, som reservanterna framställt, har icke tidigare varit känt — jag har åtminstone icke hört talas om det. De hemställa »att riksdagen må medgiva, att Kungl. Maj:t må, då skäl därtill föreligga, exempelvis beträffande specialanstalter, bevilja bidrag till erkända alkoholistanstalters driftkostnader enligt de grunder, som i motionen föreslås». För min del känner jag inte till någon annan specialanstalt än alkoholistanstalten för **kvinnor[1]**. Såvitt jag vet har det inte

kommit någon framställning från någon specialanstalt, att en sådan princip för tilldelande av bidrag skulle tillämpas. Det måste i detta fall föreligga något misstag, eller också har det måhända inverkat på reservanterna, att det blivit känt, att en nykterhetsorganisation i vårt land är betänkt på att upprätta en alkoholistanstalt. Vi hälsa denna organisation välkommen, om den är villig att åtaga sig de stora besvär och kostnader, som äro förenade med upp-

rättandet av en dylik anstalt, och även i viss mån åtager sig att bidraga till driftkostnaderna. Reservanterna kunna icke gärna ha syftat på denna anstalt, då den ännu icke grundats. De måste ha syftat på någon annan anstalt, som vi inom statsutskottets tredje avdelning icke ha kännedom om. Reservanterna ha alltså utvidgat motionärernas yrkande. Jag kan inte finna, att detta 1 någon större utsträckning stärker motionärernas sak.

Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill samtidigt uttala den fasta övertygelsen, att de synpunkter, som motionärerna hävdat, skola bli dominerande vid frågans slutliga avgöraned v. s. att staten skall vidkännas kostnaderna för alkoholistvården i vårt and.

3. Anders Andersson (Socialdemokraterna, man)

Jag har ingen särskild anledning att ingå i polemik mot utskottets representant. Jag vill endast för min del med tillfredsställelse konstatera, att vi i huvudsak äro överens om att en närmare översyn av alkoholistvården bör komma till stånd i syfte att åstadkomma fastare grunder för fördelning av platserna och en enhetligare organisation av hela alkoholistvården i vårt land. Det är enbart med tillfredsställelse jag åhört detta erkännande från utskottets talesman. Jag är fullkomligt övertygad om att om utskottets ärade föredragande litet närmare studerar vår alkoholistvård och de principer, enligt vilka statsbidrag för närvarande utgå, skall han i likhet med mig finna, hur nödvändigt och gagneligt det skulle vara för hela alkoholistvården att få en bättre fördelning av klientelet och en bidragstilldelning

Enligt Kungl. Maj:ts förenämnda förslag skulle arbetstiden för sinnessjukhusens vårdoch ekonomipersonal begränsas till 48 timmar per vecka, att träda i kraft successivt med början från 1939 års ingång. Ett genomförande av denna arbetstidsreglering beräknades kräva nyanställande av 119 manliga och 172 **kvinnliga**[1] sjukvårdsfunktionärer, 26 ekonomister och viss annan personal, samtliga såsom icke-ordinarie befattningshavare. Kostnaderna härför uppskattades till omkring 260,000 kronor under budgetåret 1938/39.

Utskottet tillstyrkte vad Kungl. Maj:t sålunda föreslagit med allenast den ändringen, att utskottet ansåg, att den till 260,000 kronor beräknade ökningen av personalkostnaderna under nästkommande budgetår skulle kunna begränsas till 200,000 kronor. I enlighet härmed skulle enligt utskottets förslag den 1 förenämnda avlöningsstat ingående anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie personal, från vilken post kostnaderna för personalförstärkningen skulle bestridas, underkastas motsvarande reduktion och förenämnda förslagsanslag således nedsättas till 15,840,000 kronor.

4. Torgil von Seth (–, man)

Herr talman! Under denna punkt har departementschefen föreslagit, att arbetstiden för vårdoch ekonomipersonal vid sinnessjukhusen skall begränsas till 48 timmar per vecka.

Det är alldeles självklart, att denna personal i många fall har en synnerligen pressande arbetsbörda och att den är i behov av all den lindring den kan få i sitt arbete. Men å andra sidan skulle ett genomförande av detta förslag medföra vissa konsekvenser, icke minst av ekonomisk art, vilka jag anser icke tillräckligt ha beaktats i den föreliggande propositionen. Enligt densamma skulle denna lag träda i kraft från och med den 1 januari 1939, och detta skulle bland

Ang. statens sinnessjukhus: avlöningar. (Forts.) annat medföra nyanställning av ett ganska stort antal såväl manliga som **kvinnliga**[1] sjukvårdsfunktionärer. Kostnaderna härför ha av departementschefen uppskattats till 260,000 kronor för nästa budgetår. Om det kunde stanna vid dessa kostnader, skulle jag givetvis ingenting ha att invända mot det föreliggande förslaget. Men då ett genomförande av detsamma otvivelaktigt drager med sig ganska betydande konsekvenser, inte minst för landstingen, då de skola ordna arbetsförhållandena och arbetstiden vid de kroppssjukhus, som äro dem underställda, är det enligt min mening litet väl tidigt att ge sig in på denna lagstiftning, i synnerhet som genom medicinalstyrelsens förordning av den 30 maj 1936 vissa anvisningar redan utfärdats rörande arbetstid och arbetsförhållanden för personalen vid kroppssjukhusen, anvisningar som i viss mån ansluta sig till de grunder, vilka av 1936 års riksdag godtagits beträffande arbetstiden vid sinnessjukhusen. I enlighet med denna medicinalstyrelsens förordning ha en hel del förändringar redan gjorts vid dessa anstalter, och det synes mig därför böra undvikas, att man redan nu så kort tid efter dessa nya anvisningars utfärdande ger sig in på en ny lagstiftning, som speciellt för landstingen kommer att medföra ganska betänkliga konsekvenser såväl i rent organisatoriskt som i ekonomiskt avseende.

Till slut skulle jag vilja påpeka, att när riksdagen vid föregående tillfällen behandlat frågan om arbetstiden för personalen vid statens sinnessjukhus har den alltid beaktat det nära sambandet mellan denna fråga och arbetstiden vid de av landsting och kommuner bedrivna kroppssjukhusen och av denna anledning ansett, att man bör gå fram med varsamhet. Jag vill, herr talman, även påpeka, att de beslut, som vid föregående tillfällen av riksdagen fattats i denna fråga, varit enhälliga.

Jag anser alltså, att den kostnadsökning, som departementschefen vwisserligen för närvarande icke upptager högre än till 260,000 kronor, dock kan medföra sådana konsekvenser, inte minst för landstingens del, att det föreligger goda skäl att dröja litet och avvakta verkningarna av de av medicinalstyrelsen förut utfärdade anvisningarna och bestämmelserna.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid denna punkt av herr Johansson i

Fredrikslund m. fl. fogade reservationen.

5. Gustav Möller (Socialdemokraterna, man)

Det är inte min avsikt att ingå på någon längre förklaring rörande det förslag, som föreligger från Kungl. Maj:ts sida om tillämpande av 48-timmarsveckan för sinnessjukhuspersonalen.

Jag vill endast understryka en enda synpunkt. Sedan omkring aderton år tillbaka ha vi en allmän lag om åtta timmars arbetsdag. Samtidigt som denna lag genomfördes, infördes avtalsvägen en motsvarande arbetstid på åtskilliga arbetsområden; vad staten beträffar t. ex. inom kommunikationsväsendet. Fjolårets riksdag beslöt en lagstiftning beträffande arbetstiden för lantarbetare, som 1 princip innebär ett tillämpande av 48-timmarsveckan, fastän arbetstiden var fördelad på olika sätt under olika delar av året. Man torde väl lugnt kunna bebåda, att nästa års riksdag kommer att besluta om införande av 48- timmarsveckan även för butiksbiträden och andra grupper av anställda. Under sådana förhållanden föreligger väl knappast någon möjlighet, att man från statens sida i längden kan handla på det sättet, att man genom lagstiftning eller andra åtgärder genomför åtta timmars arbetsdag för alla möjliga arbetarkategorier i detta land men undantager vissa små grupper av anställda, för vilka staten själv är arbetsgivare. Det går inte ihop på något sätt. Jag tycker, att detta borde vara ett tillräckligt skäl till att man numera, då aderton år förflutit, sedan det första beslutet fattades om förkortning av arbetstiden, borde

Detta är i varje fall för mig en tillräcklig motivering att uttala min tillfredsställelse över den ståndpunkt, till vilken statsutskottets majoritet har kommit. Skulle införandet av 48-timmarsveckan vid sinnessjukhusen medföra vissa konsekvenser för landstingens sjukhus, skola herrarna inte tro, att jag beklagar dessa konsekvenser. Jag har den uppfattningen, att i den mån man kan erhålla **sjuksköterskor**[3] och annan personal i tillräckligt stor utsträckning, landstingen böra som humana arbetsgivare så snabbt som möjligt införa samma arbetstid för den hos dem anställda personalen.

6. Olof Nilsson (Socialdemokraterna, man)

Herr andre vice talman! Jag vet ej, om herr Möller har behov av att få vetskap om den tacksamhet, som sjukhuspersonalen hyser för de åtgärder, som ha vidtagits för en reglering av deras arbetstid. Denna tacksamhet är också förklarlig, då själva arbetsförhållandena vid sjukhusen äro av sådan karaktär, att det antingen genom en lagstiftning eller på annat sätt måste ske en omläggning av arbetet, sådant det för närvarande är beskaffat, för att man skall få en rationell drift och en rationell ordning, med hänsyn till personalens arbetstid. Jag skulle vilja hemställa till socialministern, att när vi nu äro inne på en väg, som jag tror att vi ej kunna komma ifrån, när det gäller en reglering av arbetstiden för sjukvårdspersonalen, socialministern ej stannar enbart vid sinnessjukhuspersonalen utan i framtiden och inom en ganska snar framtid framlägger ett lagförslag om en reglering av arbetstiden för all sjukvårdspersonal här i detta land. När jag säger detta, vet jag, att sjukvårdspersonalen är enig med mig om en sådan framställning.

Den som något sysslat med sjukvårdspersonalens arbetsförhållanden måste säga, att det är en arbetargrupp, som är beklagligt eftersatt, i vad gäller både deras arbetsvillkor och deras löner. De ha en arbetstid, som är orimlig, om man jämför den med den arbetstid, som andra arbetargrupper ha. Jag har här ett par exempel på hurusom vid ett sinnessjukhus en av tillsyningsmännen har en arbetstid på 56 timmar och dessutom 18 passiva timmar per vecka samt en annan en arbetstid på 54 timmar i veckan och 17 passiva tummar. Man skulle kunna mångfaldiga exemplen, framför allt för sjukvårdspersonal vid stiftelser, privata vårdanstalter och sjukhem. Man är nästan förbluffad över att man kan behandla folk på detta sätt i nuvarande tid, som man gör med denna lägre personal. Jag överdriver ej, om jag säger, att man i många fall kan konstatera den rena utsugningen av arbetskraften.

Nu vilja reservanterna, att riksdagen skall bromsa, så att ej den övriga sjukvårdspersonalen kommer i åtnjutande av en reglering av arbetstiden. Man resonerar som så, att — det har man sina erfarenheter av — om riksdagen beslutar en reglering av arbetstiden för sinnessjukhusens personal, då kommer personalen vid landstingens och kommunernas sjukhus samt vid andra sjukvårdsinrättningar att begära en förbättring av sina arbetsvillkor. Ja, är det så konstigt? Även om riksdagen nu ej skulle besluta en arbetstidsreglering i detta fall, så måste dock denna förbättring av arbetsvillkoren komma ändå. Men jag anser, att det ej kan vara staten eller riksdagen värdigt att sätta en käpp i hjulen för en reform, som är så nödvändig, som just denna är.

Man skall erinra sig en annan sak, då man talar om arbetstiden för vår sjukvårdspersonal, och det är att denna personal ej liksom andra arbetare är fri, när dess 11 eller 12 timmars arbetsdag är slut, utan den har en viss livegenskap kvar, i så måtto att det finns ett bostadstvång för den. Den nödgas bo på arbetsplatsen, och det måtte väl vara det sämsta, som man kan tänka sig för en arbetare, att ej under fritiden få känna sig helt fri. Ett sådant förhål-

Jag vill också erinra eder, mina damer och herrar, om att vi tala vackert, och det är kanske befogat, om våra framgångar på sjukhusväsendets område. Man visar oss förnämliga sjukhus, förnämliga överläkarbostäder och sysslomannabostäder samt sjuksköterskehem. Men om herrarna se efter, hur den lägre personalen har det, så står det i en bjärt kontrast till de många gånger luxuösa bekvämligheter, till vilka den högre sjukhuspersonalen har tillgång. En överläkare har i en tidning för någon tid sedan tagit upp just detta problem om de olämpliga bostadsförhållandena för sjukhuspersonalen och påpekat, hurusom det i ett fall fanns endast tre tvättställ för 28—30 personer av den lägre personalen, som skulle försöka samsas om dessa i en våning, andra exempel att förtiga.

Jag har velat påpeka detta, när herr von Seth så här beskäftigt stiger upp och vill försöka förhindra en reform på detta område. Om det är någon mening med talet om vårt förnämliga sjukhusväsende, så bör man ej blott ha den högre personalen i åtanke utan i all rimlighets namn även dessa många tusen, som leva under arbetsvillkor, som ej kunna anses förenliga

med vad en arbetare i modern tid har rätt att begära. Framför allt bör detta gälla i fråga om statens inrättningar, vilka jag anser borde föregå med gott exempel i fråga om både arbetsvillkor och även löneförhållanden för personalen.

Det är med hänsyn till detta, som jag ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

7. Robert Jansson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! De skäl, som av reservanterna anförts mot att vi skulle gå in för ett bifall till Kungl. Maj:ts förslag, äro gamla och kända för oss inom statsutskottet och speciellt på dess tredje avdelning. Jag erinrar mig mycket väl föregående tillfällen, då vi haft att reglera arbetstiden. Den har blivit översedd under en lång följd av år. Det har emellertid visat sig alldeles omöjligt att vinna någon förståelse för den tjänstgöring, som den nu ifrågavarande personalen har, och det psykiskt pressande arbete, som den har att utföra. Jag har haft tillfälle att besöka en stor del hospital dels såsom utskottsledamot och dels i annan egenskap. Jag får för min del säga, att vad man än må anse om sjukvårdspersonalen i allmänhet, kan jag ej komma ifrån den känslan, att den personal, det här gäller, är synnerligen ansträngd och har synnerligen otrevliga tjänstgöringsförhållanden på grund av det klientel, som den har hand om. Det kommer man icke ifrån.

Jag är fullt medveten om att det förslag, som här föreligger, kommer att kosta pengar, att det kommer att bli dyrt, men ej för dyrt, därför att vi spara den mänskliga arbetskraft, som här har att utföra sin gärning, i det fall att vi ge den en human och förnuftig arbetstidsfördelning. Det är orimligt med den arbetstidsfördelning och med den arbetstid, som den för närvarande har. Därför ha vi i utskottsutlåtandet också givit uttryck för den uppfattningen, att det bör ske en förnuftig arbetstidsfördelning och en rationalisering av driften i övrigt. Genom bättre maskinella anordningar för den personal, som har att syssla med dylika ting, bör man också kunna vinna åtskilligt. Vi tro sålunda ej, att den utökning av personalbeståndet, som ifrågasatts från vissa myndigheters sida, skall bli erforderlig, om man utnyttjar alla möjligheter, som förefinnas för en rationalisering och en effektivisering av driften. Det är dessa synpunkter, som jag skulle vilja understryka, därför att de ha en synnerligen stor ekonomisk betydelse.

Vad sedan angår landstingens sjukhus och deras personal, har det ej inträf-

Ang. statens sinnessjukhus: avlöningar. (Forts.) fat någon katastrof sedan 1936, när vi gingo med på den kompromiss, som då skedde. Det satt hårt åt, men det gick dock att komma ned till 218 timmar per 30 dagar. Jag vill erinra om att det bud, som man då ansåg vara lämpligt att komma med från borgerligt håll, avsåg 224 timmar. Sent omsider gick man dock med på dessa 218 timmar. Därigenom blev det väsentligt bättre än tidigare. Men har det för den skull inträffat någon katastrof för landstingen? Säkert är förhållandet likadant nu. Jag är övertygad om att det ej kommer att inträffa någon katastrof för landstingen i fråga om möjligheten att få **sjuksköterskor**[3] eller sjukvårdspersonal överhuvud taget.

Denna reform kan emellertid ej genomföras på en gång. Vi ha också tagit oss friheten att nedsätta det anslag, som Kungl. Maj:t begärt, med 60,000 kronor, därför att vi finna det vara lämpligt, att övergången sker successivt. Därigenom bör man även kunna få tid att ordna personalbehovet. Jag menar sålunda, att om denna sak ordnas praktiskt och förnuftigt, bör den ej medföra synnerligen stora olägenheter för landstingen i fråga om möjligheterna att skaffa personal och ej heller för sinnessjukhusen. Det är klart, att det blir kostnader. Men när vi anse, att det är en rättfärdig sak, måste vi också se till, att den blir genomförd. Jag vill i detta sammanhang understryka, vad departementschefen här sagt, att det är rent orimligt, att om staten lagstiftar om en arbetstid för de i privat tjänst anställda — åttatimmarslagen avser ju huvudsakligen privat tjänst — den själv drar sig undan att vidkännas sina kostnader i detta avseende. Det är ej riktigt.

Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hem-

8. Torgil von Seth (–, man)

Herr talman! Med anledning av herr Nilssons anförande vill jag endast säga, att angående värdet av det arbete, som sjukvårdspersonalen utför, och uppskattningen av deras insats ha vi ingalunda delade meningar, utan vi äro alla överens om att denna personal utför ett arbete till de sjukas fromma, som är beaktansvärt och som givetvis måste underlättas och stödjas på alla sätt. Jag betonade också i första delen av mitt förra anförande denna synpunkt. Men vad jag också betonade var, att sjukvårdsväsendet befinner sig i en hastig frammarsch och att utvecklingen går så fort, att här fordras anställande av nya grupper av såväl manlig som **kvinnlig**[1] personal. I detta avseende har jag också påpekat, att vi ej kunna fullt överblicka verkningarna av de bestämmelser, som medicinalstyrelsen utfärdade i maj 1936, och att det därför är skäl att gå fram med en viss varsamhet.

För min del skulle jag vilja säga, att man också bör tänka på de sjuka, på den utveckling som sjukvården fått och på den överbeläggning, som äger rum på våra sjukvårdsanstalter. Åtminstone har jag hört de farhågorna uttalas från ganska erfarna sjukvårdsmän, att om man nu beslöte denna inskränkning av arbetstiden och på den grund finge nyanställa personal vid dessa sjukhus, vore det fara värt, att landstingen ej kunde vara med i konkurrensen och att det följaktligen skulle bliva vissa svårigheter att anställa personal vid de inrättningar, som drivas av landstingen.

Det är med hänsyn till detta och till vad jag förut sagt, som jag anser, att man bör gå fram med en viss försiktighet. Men när det gäller värdet av den insats, som sjukvårdspersonalen gör, och att dess arbete bör understödjas och på allt sätt underlättas, därom råder ingen meningsskiljaktighet.

9. Anders Råstock (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag är i väsentliga delar förekommen av herr Jansson i Falun. Jag begärde emellertid ordet för att säga, att jag tror, att det låg en viss överdrift i herr von Seths omtanke om landstingen. Lands-

Ang. statens sinnessjukhus: avlöningar. (Forts.) tingen ha nämligen redan i stor utsträckning börjat minska arbetstiden för den personal, som de ha, i en takt, som man för blott tio år sedan ej tänkte sig. Svårigheterna gå nog 1 detta fall att övervinna. Jag vill endast peka på den möjlighet, som också herr Jansson i Falun i detta fall antydde, nämligen att man kan rationalisera. Jag är fullständigt ense med honom därom. Det kanske går att klämma ihop dagsschemat, så att man ej behöver börja så tidigt och sluta så sent, som hittills varit fallet. En sådan metod ha vi försökt i Örebro på förslag av vår överläkare, och det har visat sig, att det går mycket bra.

När jag nu har ordet, skall jag be att få säga till herr Nilsson i Göteborg, att det finns en sak, som man ej kan komma förbi, när det gäller att ordna bostadsfrågan för landstingens sjukvårdspersonal, och det är, att landstingen måste ha tid på sig att göra bostäder i ordning. Jag tror emellertid, att det är ganska få ställen, där förhållandena äro så primitiva, som herr Nilsson påpekade. Jag skulle vilja sedan privat av herr Nilsson få höra, var det är man har det ställt på det sättet, ty jag har att göra med den saken även i landstingsförbundet. Där ha vi ställt oss på den ståndpunkten, att man ej kan tillmötesgå alla krav på en gång. Vissa krav kan man åtminstone ej tillmötesgå i den utsträckning, som personalen begär. I detta fall vill jag göra en personlig deklaration, som jag har avgivit till vederbörande sjukvårdspersonal i det län, som jag representerar, och jag anser, att det kan vara skäl i att upprepa den även i andra kammaren i denna debatt om hithörande ting.

Jag har för min del intagit den ståndpunkten, att det är ett alltför långt gående krav, när man begär, att de nyanställda biträdena skola ha eget rum. Det skola de ha, när de varit kvar så pass länge, att man kan räkna med att de stanna 1 landstingets tjänst. Efter två eller tre år är det rimligt, att de få det. Men att en människa, som kommer från ett hem, där det kanske varit fyra, fem å sex i samma rum, omedelbart som **hon²** kommer och anmäler sig och får anställning som biträde, skall ha rätt att kräva och att landstinget skall ha skyldighet att tillhandahålla **henne²** ett eget rum, tycker jag är att driva saken litet för långt. När vi haft att behandla dylika framställningar från sjukvårdspersonalförbundet, som vi närmast haft att göra med, ha vi sagt, att vi skola vid nybyggen beakta de krav, som personalen framställt. Vi ha då tänkt oss och 1 vissa fall redan gått in för, vad vi anse rimligt, nämligen att bostäderna ordnas så, att det blir högst två unga människor i samma rum. Desslikes är det vår avsikt — det är personalen med om, och den har till och med begärt det — att ordna det så, att de som bo i samma bostad få sin lediga tid på samma gång.

Det är klart, att om man icke hade exempel på huru det går, när man i stället för bostäder lämnar ut kontant ersättning, så kanske frågan kunde te sig litet annorlunda, men detta är dock ett så vittutseende program, att man är tvungen att ta tid på sig för att ordna denna sak.

Jag nämnde i förbigående, att man gjort vissa erfarenheter, huru det går till, när man tillhandahåller ersättning i stället. Då går det till på det sättet, att vederbörande slå sig ihop

och hyra ett billigt rum, där de ha det icke alls så bekvämt i regel som i de nybyggda, mera moderna bostäderna vid de större sjukhusen. Det är ett faktum, som man icke kommer ifrån. Och vill man ha en ordentlig bostadshygien till stånd, är det mycket bättre, att man från det allmännas sida gör uppoffringar, går före med gott exempel och ger vederbörande rymliga och bekväma bostäder. Om därvid de allra yngsta få lov att vistas två i varje rum, är detta icke något överdrivet krav enligt min uppfattning från landstingens sida. Jag har velat säga dessa ord för att ställa denna sak i riktig belysning.

10. Ola Isacsson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Ett av de skäl, som här anförts såsom avgörande för reservanterna att gå emot förslaget, är omsorgen om landstingen. Nu har herr Råstock nyss vidrört denna synpunkt, och jag skall därför kunna fatta mig ganska kort. Jag vill emellertid säga till herr von Seth och till reservanterna, att när de tyckas vara så rädda för att staten skulle komma att gå före eller att staten skulle pressa landstingen i denna sak, så är detta bekymmer ganska obefogat, eftersom en hel rad landsting redan infört 8 timmarsdagen vid sina sjukhus och anstalter. Och vad är anledningen härtill? Jo, det är helt enkelt insikten om att det icke längre går att köra med personalen på det sätt som tidigare skett. Det är icke så få misstag som begåtts vid vissa sjukhus. Det har varit ett observandum för sjukhusledningarna, som de glädjande nog tagit rättelse av.

Det är vidare icke riktigt, som reservanterna resonera, att förkortningen av arbetstiden skulle komma att betyda en oerhörd kostnadsökning. Det är klart, att någon utökning av personalen måste ifrågakomma, men om man tar hänsyn till det förhållandet, som herr Råstock för övrigt vidrörde, att det finns möjligheter att organisera och att förlägga arbetstiden vid sjukhusen på ett helt annat och förnuftigare sätt än som hittills varit fallet, torde denna stora kostnadsökning i mycket väsentlig grad undvikas. Vi ha exempel också på den saken, som jag emellertid icke här skall trötta med att anföra.

Herr von Seth slutade med att säga, att vi böra väl också tänka något på de sjuka. Ja, jag skulle vilja säga, att det är just med tanke på de sjuka, som vi måste gå in för en rätt avsevärd arbetstidsförkortning vid sjukhusen. Om vi icke tänka på dem utan låta de ekonomiska synpunkterna vara avgörande och av sparsamhetsskäl fortsätta att tröttköra personalen som hittills, då kommer det att gå som det gått i vissa fall, och det är klart att det icke blir till gagn för de sjuka.

Herr talman! Jag ber för min del att få förena mig med dem, som yrkat bifall till utskottets hemställan.

11. Olof Nilsson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Herr von Seth var angelägen att understryka, att han med sitt ställningstagande icke ville undervärdera sjukvårdspersonalens arbete, utan det var av helt andra orsaker, som han gick emot den kortare arbetstiden. Ja, det må så vara, herr von Seth, men vad har en arbetare för nytta eller för glädje av sitt arbete, om arbetsgivaren förklarar, att allt är gott och

väl, och ingenting vill göra för att förskaffa arbetstagaren, arbetaren, drägliga arbetsvillkor? Det vore just att göra som det står någonstans skrivet, att man nalkas sjukvårdspersonalen med sina läppar, men att ens hjärta är långt ifrån den.

Han anförde vidare, att man skulle tänka på de sjuka, när man i detta sammanhang vill gå till en arbetstidsförkortning. Ja, det är nog så riktigt, och jag har den erfarenhet av det arbete jag haft på detta område, att om icke sjukvårdsanstalterna eller sjukhusen överhuvud se till att skaffa sjukvårdspersonalen bättre arbetsvillkor, så inträder en personalbrist på vederbörande inrättningar, med resultat att man får en sekunda arbetskraft. På alla andra områden, där den **kvinnliga**[1] arbetskraften för närvarande konkurrerar, är det så, att den har det bättre än på sjukhusen. Jag har varit på ålderdomshem och privata sjukvårdsinrättningar, där arbetsförhållandena för sjukvårdspersonalen varit ännu sämre än någon annanstans, där man beklagat sig över, att man icke fick tillräcklig arbetskraft och att den arbetskraft som anmälde sig varit sekunda. Och vilka är det som få lida för en sådan utveckling, herr von Seth, om icke just de sjuka, som skola bli behandlade av en mindre kvalificerad

Så ville herr Råstock göra en erinran, i det han ansåg, att sjukvårdspersonalen ställde för höga krav, när den begärde ensamma rum. Ja, det är ju olika uppfattningar i den frågan. T. o. m. en lantarbetare har ensamt rum i våra dagar, även om han får dela det med kreaturen i ladugården. Den personal det här gäller tjänstgör ju i mycket stor utsträckning under nätterna, och det händer, att de två, som dela ett rum, icke ha nattjänstgöring samtidigt, utan denna går växelvis, så att nattjänstgöringen växlar per vecka, den ena har dagtjänstgöring och den andra nattjänstgöring. Då begär personalen, att dessa skola få ensamt rum, därför att har man gått i sitt arbete en hel dag och i ett arbete av den irriterande och ansträngande natur som sjukvårdsarbetet innebär, är det ju en ganska ringa begäran att få ensamt rum. Jag erkänner, att detta betyder för sjukvårdsinrättningarna och för landstingen ganska stora kostnader, men man måste ju se till det rent mänskliga i detta sammanhang.

När jag framdrog exempel på huru sjukvårdspersonalen 1 vissa fall har det i avseende å bostad, gällde detta exempel icke landstingens sjukvårdsinrättningar, och jag har ingen anmärkning i något avseende att göra mot förhållandena på detta område, som är av den karaktär, att man icke skulle kunna lösa dylika förhållanden genom förhandlingar mellan resp. fackorganisation och vederbörande arbetsgivare. Det är icke min mening att landstingen på något som helst sätt äro motståndare till eller icke förstå personalens krav på att få ordentliga arbetsvillkor. Tvärtom har jag endast kunnat konstatera ett gott samarbete på detta område för landstingens vidkommande, men det är klart, att även där finns det meningsskiljaktigheter, och även där kan det uppstå tvistigheter om hur en sak skall ordnas. Låt mig taga ett sådant exempel som herr Råstock påpekade. Vad jag har velat i detta sammanhang trycka på är, huruvida det alltid är så nödvändigt att vidhålla kravet på att personalen skall bo inom anstalten. Det är på den punkten jag är litet tveksam, huruvida det alltid kan vara nödvändigt, detta så mycket mera som jag vet, att även läkarna i många fall hysa delade meningar om huruvida detta bostadstvång för personalen är så lämpligt. För

personalens vidkommande anser jag det icke alls vara tilltalande och i högsta grad obekvämt med anledning av de många olägenheter som ett sådant bostadstvång innebär.

12. Karl Kilbom (Sveriges kommunistiska parti, man)

Herr talman! Då denna fråga är av stort samhälleligt intresse, har jag tagit mig friheten begära ordet för att bidraga till belysning av de förhållanden på området som äro rådande. Det synes mig, att man nog borde taga litet mera enhetligt och mångenstädes allvarligare på detta problem än vad som för närvarande är fallet.

Det är obestridligt för det första, att det råder en till sina verkningar ödesdiger brist på viss sjukvårdspersonal, som i sin tur är att återföra till att utvecklingen har gått litet för hastigt. Det ökade behovet av personal har icke hunnit bli tillgodosett så, som man skulle ha önskat. Därtill har också de villkor bidragit, under vilka personalen har arbetat. Det är således alldeles obestridligt, att den långa arbetstiden, de tunga och onödigt svåra förhållandena exempelvis i fråga om **sjuksköterskorna³** i mycket stor utsträckning ha bidragit till att skapa en situation, som man nu tämligen allmänt, skulle jag tro, på sjukhusen betecknar såsom högst beklaglig.

Jag talade häromdagen, bara för tre dagar sedan, med en av ledarna för ett mycket stort område av sjukvården, och han bekräftade, att man hade utannonserat en rad av platser lediga men icke kunde besätta dem. Jag ställde honom då den frågan, om det icke fanns möjlighet att flytta över en del som nu gå inom den privata sjukvården till anstaltvården och så ersätta de privata vår-

Det skall samtidigt även sägas, att det största hindret härvidlag måhända ligger, utom i arbetets säregna karaktär, dels däri att både **sköterskorna³** själva. då de komma till en viss ålder, och icke minst läkarna, äro ytterligt vanekonservativa. De ha ett bra argument, det skall också medges: de sjuka tåla inga förändringar, säga de. Det är naturligtvis delvis riktigt. Men om en gång förändringarna äro genomförda, så undrar jag, om icke de sjuka skulle finna sig i dem.

Nu har det från statens sida liksom från de olika kommunernas och landstingens sida, anförts ett argument, som måste betraktas såsom mycket starkt, och som väl tämligen snart för oss alla kommer att te sig ännu starkare: förändringar på detta område äro förenade med stora kostnader. Jag tror, att det vore mycket olyckligt, om vi, som sitta i riksdagen, i landsting eller stadsfullmäktige eller vad det nu är, och ha att övervaka och handlägga sjukvårdsärenden, skulle förbise detta argument.

Men vad sjukvårdspersonalen beträffar, så undrar jag ändå om man icke bör taga hänsyn till att den bör, som jag förut sade, ha det bäst. Jag kan icke hjälpa, herr andre vice talman, att när man sitter och jämför löneläget för olika grupper i samhället och finner, att exempelvis en polisöverkonstapel har en lön lika stor som en folkskollärares, då hajar åtminstone jag till och tycker: men kan det här ändå vara riktigt? Och när man sedan jämför dessa löner med exempelvis en kvalificerad **sjuksköterskas³** lön och tar hänsyn till att **hon²** 1 regel har

realskoleexamen, att **hon²** därefter har tre och ett halvt års utbildning, som både kostar pengar och enormt med arbete, och tar hänsyn till **hennes²** lön, **hennes²** fritid, **hennes²** pensionsförhållanden och den beskedlighet, som **hon²** och **hennes²** kår visa, då det gäller att inför samhället göra sina krav gällande, då har jag för min del icke kunnat undertrycka den reflexionen: är detta så alldeles rättvist fördelat med hänsyn till det medborgerliga värdet och de mänskliga behoven.

Ang. statens sinnessjukhus: avlöningar. (Forts.) Jag skulle emellertid vilja vädja till dem det vederbör och till statsutskottet, fastän jag medger, att jag icke kan finna någon avoghet från deras sida emot att man skall tillgodose sjukvårdspersonalens intressen, jag skulle vilja vädja till er alla och envar att, när sådana här frågor i framtiden komma upp, tänka på de sämst ställda **sjuksköterskorna³**.

13. Solveig Rönn Christiansson (Vänsterpartiet, woman)

Herr talman! Herr Nilsson i Göteborg har talat om olika slag av sjukhuspersonal. Jag vill därvidlag reagera mot uttrycket lägre personal, därför att ju all personal är lika nödvändig för sjukhuset. Beträffande dåliga bostäder skall jag be att få draga fram ett exempel från en stad som Göteborg. Statsrådet Möller var för någon tid sedan där nere för att inviga ett elevhem för **sjuksköterskorna³**, och statsrådet yttrade då, att han var tacksam för att personalen fick ett nytt och präktigt bostadskomplex. Men den övriga sjukhuspersonalen, den s. k. lägre, den fick krypa in i de där kyffena, som icke voro fina nog åt **sjuksköterskorna³**; den fick också övertaga de nönlen och annat bohag, som heller icke passade i de nyblivna **sköterskornas³**

Herr von Seth deklarerade sin aktning för det arbete, som utföres av sjukhuspersonalen. Ja, det kostar givetvis ingenting att säga på det sättet. Men när man vill göra någonting för att i handling bevisa denna aktning mot denna stora kår, då skall man enligt herr von Seth iakttaga en viss försiktighet.

Herr Råstock anförde som exempel, att man icke bör taga hänsyn till personer, som tidigare av sina familjeförhållanden varit tvingande att bo både två och flera i sina rum. Att sedan för denna personal begära egna rum anser herr Råstock icke vara riktigt. Skall alltså deras nödläge och ekonomiska betryck vara utslagsgivande för att de allmänna inrättningarna skola sänka bostadsstandarden?

Vad beträffar frågan, huruvida sjukvårdspersonalen i bostadshänseende skall vara fästad vid arbetsplatsen eller icke, bör principen vara den, att personalen skall bo utanför arbetsplatsen. Sedan kan det ju bli en annan fråga, huruvida man har möjlighet att så skyndsamt som önskligt vore genomföra denna princip.

14. Anders Råstock (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag väntade mig ju icke någon större grad av förstående för de synpunkter jag framförde. Men sådana vantolkningar, som den sista talaren, **fru²** Rönn-Christiansson, gjorde sig skyldig till, trodde jag ändå icke skulle behöva förekomma, när jag uttryckte mig så pass

tydligt. Jag sade det, att jag tyckte, det var att marschera något för fort, när en person, som kanske tidigare hade bott i ett rum tillsammans med fem eller sex andra, kommer och begär, att **hon²** i anstalten omedelbart skall ha ett eget rum i löneförmån. Jag sade visst också, att när dessa hade varit anställda så pass länge som ett par år eller tre, så att landstinget kunde räkna på att få ha dem kvar, så ansåg även jag, att de borde få ensamt rum. Och jag vågade tilllägga, att landstingen och det allmänna i övrigt böra gå före med gott exempel och skapa rimliga och goda och bekväma bostäder. Jag vågar påstå, att jag alldeles icke har deklarerat någon avog inställning till detta problem utan alldeles tvärtom. Jag vill bara ha det så, att det skall vara någon måtta på pretentionerna också, och att landstingen böra få tid på sig för att ordna denna fråga på ett tillfredsställande sätt.

Sedan hörde jag till min tillfredsställelse herr Nilsson säga, att han icke hade något otalt med landstingen i det här ärendet. Och det var ju bra. Men av det anförande han höll och av vad **fr u²** Rönn-Christiansson nu anfört framgår ju, att det är särskilt svåra förhållanden i Västsverige. Varför taga icke **fru²** Rönn-Christiansson och herr Nilsson i Göteborg itu med detta och försöka reformera hemma? Det är ju ett ordspråk, som säger, att man bör börja där. Jag skall åtminstone göra vad jag kan på det ställe, där jag representerar det allmänna, och jag gör det i detta fall i egenskap av ledamot av statsutskottet. Jag har hemställt av alla mina krafter, om jag så får säga, att Kungl. Maj:ts proposition i denna fråga skall bifallas, just därför att jag anser, att den personal, det här är fråga om, måste ha en dräglig arbetstid, om den överhuvud skall stoppa.

Om ni sedan har läst en bok, som utkom någon gång i fjol, och som jag för min del icke vill ge mycket för, men som innehåller åtskilliga utfall mot sjukvårdspersonalen, så kanske ni kunna förstå, att det ibland kan komma i fråga, att just den dagliga samvaron med till sinnet sjuka människor verkar i hög grad deprimerande på personalen. Det har icke författaren till nämnda bok tagit någon hänsyn till, ty han skär alla över en kam.

Herr talman! Då vi resonera om landsting, hör detta egentligen icke hit, utan det bör avhandlas på ett annat ställe. Jag ansåg mig emellertid böra bemöta vad herr von Seth anförde om svårigheterna för landstingen, och detta är anledningen till att jag överhuvud engagerat mig i denna debatt.